PROTOCOLLO 14

Autogestione nella fase acuta

Insegnare le strategie quotidiane per ridurre il carico sull'ATM

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Acuta e subacuta	Mialgia, artralgia	10 a 15 minuti	Prime 3 sedute

Indicazioni

- ✓ Dolore acuto o riacutizzazione
- ✓ Prime settimane di trattamento
- ✓ Pazienti con parafunzioni diurne

Controindicazioni e precauzioni

- ! Red flags non escluse dal medico
- ! Peggioramento rapido e non spiegato dei sintomi
- ! Condizioni sistemiche non controllate
- ! Assenza di consenso informato del paziente

Posizionamento

Paziente: seduto.

Fisioterapista: di fronte al paziente con la scheda di autogestione.

Esecuzione passo dopo passo



Dieta morbida
Cibi morbidi, piccoli bocconi, evitare gomme da masticare.



Riposo funzionale
Evitare aperture ampie e sbadigli forzati.



Posizione di riposo
Labbra chiuse, denti separati, lingua al palato.



Calore o freddo
Applicare secondo la preferenza e la fase.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Durata	2 a 3 settimane
Verifica	a ogni seduta
Supporto	scheda consegnata al paziente

Criteri di rivalutazione

LIMITAZIONE FUNZIONALE
____ / 10
masticare, parlare, sbadigliare

DOLORE (NRS)
____ / 10
peggiore della settimana

ADERENZA
____ %
esercizi svolti a casa

Punti chiave

- ✓ Le strategie semplici sono la base del trattamento
- ✓ Personalizza in base alle abitudini
- ✓ Rinforza i comportamenti corretti

Errori da evitare

- ! Prescrivere una dieta liquida prolungata
- ! Immobilizzare completamente la mandibola
- ! Consegnare indicazioni senza spiegazioni

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Promemoria della posizione di riposo	Controllare denti separati e lingua al palato	ogni ora con un promemoria

! **Nota clinica.** L'autogestione è raccomandata come primo intervento in quasi tutti i quadri di DTM.

Bibliografia essenziale

1. List T., Jensen R.H. Temporomandibular disorders: old ideas and new concepts. Cephalalgia. 2017;37(7):692–704.
2. Moseley G.L., Butler D.S. Fifteen years of explaining pain: the past, present, and future. J Pain. 2015;16(9):807–813.